



CONSULTORIO DE ECOGRAFÍAS

ECOGRAFÍAS ABDOMINALES- GINECOLÓGICAS-MAMARIAS-PARTES BLANDAS- MIOARTICULARES- ECODOPPLER-
ECODOPPLER OBSTÉTRICO-ECOPOWER ARTICULAR. BIOPSIAS: MAMARIAS- PROSTÁTICAS- PAAF DE TIROIDES

ZURITA N° 547- CEL: (383) 4993334

PACIENTE: MALDONADO ENRIQUE DANIEL

D.N.I.: 24.010.663

FECHA: 09/09/2026

DOPPLER ESPLENO-PORTAL:

ESTUDIO MORFOLOGICO:

- Hígado de forma y tamaño normal, bordes regulares. Parénquima sutilmente inhomogéneo, con esteatosis severa difusa, sin evidencia de lesiones nodulares focales definidas.
- Vía intra-extrahepática sin dilatación. Colédoco de calibre normal.
- Vesícula de forma y tamaño normal de paredes finas.
- Bazo de tamaño normal, de ecogenicidad homogénea. Mide 104 x 45 mm de diámetro.

ESTUDIO DOPPLER COLOR:

. Vena porta permeable, calibre normal de 12 mm, con flujo de hepatópeto, onda espectral con ondulación ante la respiración conservada, con una velocidad de 17-18 cm/seg (variando con los movimientos respiratorios)

Ramas intrahepáticas portales permeables.

. La arteria hepática presenta patrón de flujo hepático de baja resistencia normal, con flujo anterógrado continuo, ascenso sistólico rápido y baja pulsatilidad.

Índice de Resistencia: 0.62.

. Las venas suprahepáticas congestivas, con el flujo hepatofugo. Al estudio doppler espectral, se observa pérdida de la morfología trifásica, con anulación de la fase diastólica retrograda, en fase sistólica se observa monofásico. Lo que indica disminución de la distensibilidad hepática.

. Vena mesentérica superior permeable, ascenso sistólico rápido diástole conservada.

. Vena esplénica permeable, de calibre conservado, sin signos de trombosis. Mide 7 mm (para un normal hasta 9mm)

Conclusión: alteración en la distensión hepática demostrado por falta de patrón-retrogrado en venas superhepáticas. Resto del Doppler del eje esplenoportal dentro de parámetros normales.

Acevedo María de los Angeles
MEDICA MP N° 2718
DIAGNOSTICO POR IMAGENES ME 1402

